Lic. Valeria Bohorques
Lic. Carlos Sena

TRANSFORMACIONES DEL CUIDADO Y HUMANIZACIÓN

Expertise de enfermería e impacto de los factores ambientales en el estrés del prematuro en UCIN

Sena.[1], Bohorques.[2]

[1] Hospital de Clínicas "José de San Martín", Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires (UBA). [2]

1 INTRODUCCIÓN

La inmadurez neurológica del recién nacido prematuro limita su capacidad adaptativa frente a la sobrecarga sensorial de la UCIN, donde picos de ruido superiores a 120 dB y la exposición lumínica continua alteran su estabilidad hemodinámica (Vargas et al., 2018). Aunque se reconoce que la luz ciclada y la atenuación acústica favorecen el neurodesarrollo y reducen la estancia hospitalaria (Morag & Ohlsson, 2016; Almadhoob & Ohlsson, 2020), aún falta precisar el grado real de expertise y la interpretación clínica que aplica el personal asistencial ante estos estresores. Determinar este nivel de conocimiento en enfermería es crucial para implementar intervenciones individualizadas que mitiguen el impacto fisiológico y optimicen la calidad del cuidado neonatal.

2 OBJETIVOS

Objetivo General: Determinar el grado de expertise del personal de enfermería del turno mañana del servicio de neonatología sobre los efectos ambientales generadores de estrés en neonatos prematuros.

Objetivos Específicos: Identificar la percepción del personal sobre los principales factores estresantes ambientales presentes en la UCIN.

Describir las estrategias de mitigación ambiental y cuidado del neurodesarrollo aplicadas habitualmente en la práctica asistencial diaria.

Propósito de la Experiencia: Evaluar el conocimiento práctico e interpretación clínica del personal asistencial ante los estresores ambientales de la UCIN. Esta experiencia busca identificar brechas formativas e impulsar protocolos estandarizados de cuidado individualizado para optimizar la estabilidad hemodinámica y el neurodesarrollo de los prematuros hospitalizados.

3 METODOLOGÍA

Diseño: Estudio cuantitativo, descriptivo, no experimental y de corte transversal.

Ámbito y período: Servicio de Neonatología (2.o Piso, Sala 6) del Hospital de Clínicas "José de San Martín", desarrollado entre marzo y septiembre de 2026.

Población o participantes: Muestra censal de enfermeras asistenciales del Turno Mañana (atención directa continua).

Intervención o procedimiento:

1. Identificación y reclutamiento del personal del turno mañana.

2. Solicitud e instructivo de llenado del cuestionario.

3. Recolección de cuestionarios anonimizados.

4. Sistematización de datos.

Instrumentos y análisis: Cuestionario anónimo semiestructurado ad-hoc estructurado en variables sociolaborales, expertise autopercibido, evaluación clínica y estresores. Análisis descriptivo mediante frecuencias absolutas y porcentuales.

Aspectos éticos: Participación voluntaria con Firma de Consentimiento Informado previo, aval institucional del servicio e imposibilidad de rastreo de identidad (sin nombres, iniciales, historia clínica ni registros fotográficos).

Descripción de la experiencia: Entre marzo y septiembre de 2026, se evaluaron los conocimientos de 6 enfermeras de la UCIN sobre el estrés de los prematuros y las medidas para reducirlo. Los resultados permitieron identificar oportunidades de mejora en el cuidado del neurodesarrollo.

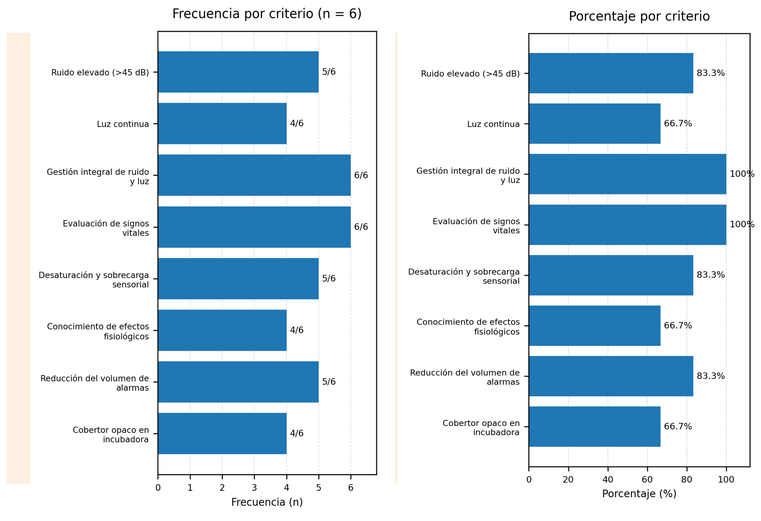
Contacto: valeriaborhorques12@gmail.com

4 RESULTADOS

Tabla de Resultados Principales (n = 6)

Variable / Criterio evaluado	Frecuencia (n/6)	Porcentaje (%)
OE1: Identificación de estresores principales		
Reconoce el ruido elevado (>45 dB) como estresor crítico	5/6	83,3 %
Reconoce la luz continua como estresor crítico	4/6	66,7 %
Considera prioritaria la gestión integral de ambos estresores	6/6	100 %
OE2: Valoración clínica de signos vitales (FC, FR,)		
Evalúa constantemente signos vitales ante picos de estrés	6/6	100 %
Asocia la desaturación a la sobrecarga sensorial	5/6	83,3 %
Percibe poseer expertise suficiente sobre efectos fisiológicos	4/6	66,7 %
OE3: Estrategias de mitigación ambiental		
Disminuye el volumen de alarmas de equipos/monitores	5/6	83,3 %
Utiliza cobertor o manta opaca sobre la incubadora	4/6	66,7 %
Aplica atenuación de voz y manipulación suave de mobiliario	—	—

Figura 1. Tabla de resultados principales



Respuesta al OE1 (Estresores ambientales): El 83.3% (5/6) del personal identificó el ruido elevado como el principal estresor ambiental, mientras que el 66.7% (4/6) señaló la luz continua continua. El 100% (6/6) consideró prioritaria la abordabilidad conjunta de ambos factores.

Respuesta al OE2 (Signos vitales y expertise): El 100% (6/6) de las enfermeras evalúa siempre las variaciones en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno ante estímulos ambientales. El 83.3% (5/6) asocia las fluctuaciones de la saturación directamente a la sobrecarga sensorial, y el 66.7% (4/6) autopercibe un nivel alto de expertise teórico-práctico.

Respuesta al OE3 (Estrategias aplicadas): En la práctica diaria, el 83.3% (5/6) ajusta habitualmente el volumen de las alarmas, el 66.7% (4/6) aplica cobertores para ciclado lumínico en incubadoras y el 50% (3/6) mantiene moderación del tono de voz y cierre suave de compartimentos.

Descripción de la experiencia: Se logró caracterizar el perfil de competencias del personal del turno mañana, confirmando un sólido reconocimiento de los signos vitales como indicadores clínicos de estrés. Como principal dificultad se presentó la carga asistencial del turno y la reducida muestra de estudio (n=6), lo que demandó flexibilidad en los tiempos de respuesta. Se aprendió que, si bien existe una alta adhesión al manejo de alarmas y luz, la modulación del tono de voz y el cuidado en el manejo del mobiliario requieren un refuerzo continuo mediante capacitaciones dinámicas en servicio.

5 CONCLUSIONES

MENSAJE CLAVE

El personal de enfermería posee un elevado expertise en la interpretación de signos vitales como indicadores de estrés neonatal, alcanzando un 83.3% de adherencia en el ajuste de alarmas. Sin embargo, resulta indispensable estandarizar protocolos institucionales de gestión acústica y lumínica para garantizar un cuidado integral centrado en el neurodesarrollo del prematuro.

Se identificó que el personal reconoce el ruido y la luz como factores de estrés en los prematuros, valora los signos vitales para detectar alteraciones y aplica medidas de mitigación ambiental. La experiencia permitió reconocer fortalezas y aspectos por mejorar. Como limitaciones, se destacan la participación de solo seis enfermeras y la carga asistencial, que dificultó la recolección de datos. Los resultados describen la realidad del turno mañana y no pueden generalizarse a todo el servicio.

6 APORTE A ENFERMERÍA

Este estudio optimiza la gestión al identificar brechas en el manejo acústico-lumínico y fortalece la formación continua del equipo. En el cuidado, promueve un entorno neuroprotector que reduce el estrés fisiológico del prematuro. Sus hallazgos son aplicables a otras áreas críticas como pediatría o terapia intensiva general para estandarizar protocolos de confort ambiental.

7 REFERENCIAS

- Almadhoob A, Ohlsson A. Reducción de sonido para la prevención del deterioro del neurodesarrollo en lactantes prematuros ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Cochrane Database Syst Rev. 2020;(1):CD010333.
- https://doi.org/10.1002/14651858.CD010333.pub3
- Morag I, Ohlsson A. Luz ciclada para el cuidado de bebés prematuros y de bajo peso al nacer en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Cochrane Database Syst Rev. 2016;(8):CD006982.
- https://doi.org/10.1002/14651858.CD006982.pub3
- Vargas CDA, Luna MM, Braverman BA, Bronstein AB, Leboreiro JI, Zapata IB.
- Medición y análisis de los niveles de ruido en una unidad de cuidados intensivos neonatales. An Med Asoc Med Hosp ABC. 2018;63(3):165-168.
- Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. Metodología de la investigación. 5a ed. McGraw-Hill; 2010.